AOU di Valcavera
Dipartimento di Diagnostica Avanzata
SC Anatomia Patologica e Ematopatologia
Direttore f.f.: Dott. Stefano Benussi

Strada di Fiume 447
34149 Trieste
Tel. 040 3994821

REFERTO ISTOPATOLOGICO

Biopsia escissionale linfonodale con indagini immunofenotipiche

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**Furlan**	Nome:	**Davide**
Nato a:	**Trieste**	Il:	**27/05/2000**
Cod. fiscale:	**FRLDVD00E27L424G**	Sesso:	**M**

Riferimento:	EM-25-00932	Data intervento:	2 luglio 2025
Reparto inviante:	SC Chirurgia Generale (Dott. Marko Zuliani)	Data accettazione:	03-07-2025
Clinico di riferimento:	Dott.ssa Elisa Vascotto, Ematologia	Data referto:	14/07/2025

Blocchetto: EM25-00932-A2

QUESITO E NOTIZIE CLINICHE

Giovane pz. di aa. 25, studente universitario, con linfoadenomegalia laterocervicale sinistra e sovraclaveare da circa due mesi, prurito e sudorazioni notturne. TC: pacchetto linfonodale mediastinico anteriore di 6,5 cm. Il paziente Furlan riferisce che la madre, sig.ra Nadia Kosovel, è stata trattata in passato per tiroidite di Hashimoto. Si richiede diagnosi con priorità B.

MATERIALE INVIATO

A) Linfonodo laterocervicale sinistro, livello IV, asportato in toto (blocchetti A1-A4).
B) Prelievo a fresco per citofluorimetria e congelamento (biobanca, con consenso).

DESCRIZIONE MACROSCOPICA

Linfonodo di cm 3,2 x 2,1 x 1,8, di consistenza duro-elastica, con capsula ispessita. Al taglio la superficie è suddivisa in noduli biancastri separati da setti fibrosi.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Sovvertimento dell'architettura linfonodale per la presenza di noduli delimitati da bande di fibrosi collagena birifrangente. Nei noduli, su fondo infiammatorio misto ricco di linfociti, eosinofili e istiociti, si osservano cellule di grandi dimensioni, mono- e plurinucleate, con nucleoli eosinofili prominenti (cellule di Reed-Sternberg e varianti lacunari). Focolai di necrosi con orletto di cellule neoplastiche (aspetto sinciziale focale).

IMMUNOISTOCHIMICA

Anticorpo	Cellule neoplastiche	Note
CD30	positivo (membrana e Golgi)	Diffuso nelle cellule grandi
CD15	positivo in circa il 60%	Pattern a dot paranucleare
PAX5	debolmente positivo	Più debole rispetto ai linfociti B reattivi
CD20	negativo	Positivo nei piccoli linfociti B di fondo
CD45	negativo	-
MUM1	positivo forte	-
EBER (ISH)	negativo	Assenza di infezione latente da EBV nelle cellule neoplastiche
Ki-67	elevato	Cellule neoplastiche e componente reattiva

DIAGNOSI

Linfonodo laterocervicale sinistro: linfoma di Hodgkin classico, sottotipo sclerosi nodulare (grado 2 sec. BNLI per la presenza di aree sinciziali).

Il caso è stato sottoposto a revisione collegiale con la Dott.ssa Chiara Peric (ematopatologia) in data 11/07/25 con concordanza diagnostica. Risultato comunicato telefonicamente alla Dott.ssa Vascotto il 14.07.2025 per l'avvio della stadiazione PET e la preservazione della fertilità.

Referenti del caso

Ruolo	Nominativo	Contatto
Ematologo curante	Dott.ssa Elisa Vascotto	int. 040 3994377
Patologo refertante	Dott. Stefano Benussi	Segreteria AP
Familiare di riferimento	Nadia Kosovel (madre)	+39 333 8045 172

Il Dirigente Medico

Dott. Stefano Benussi

SC ANATOMIA PATOLOGICA
Dott. S. Benussi
Ord. Medici TS n. 3712

Revisione

Ematopatologa

Dott.ssa Chiara Peric

Trieste, 14/07/2025